



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA**

JANAINA BARBOSA DA SILVA

**O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO LGBTQIA+ NO COTIDIANO
DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

Porto Alegre,
2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA

JANAINA BARBOSA DA SILVA

**O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO LGBTQIA+ NO COTIDIANO
DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

Dissertação de mestrado a ser apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito obrigatório para a conclusão e obtenção do título de Mestre em Saúde Coletiva.

Orientador: Prof. Dr. Frederico Viana Machado

Área de concentração: Saúde coletiva

Linha de pesquisa: Saúde, sociedade, educação e humanidades

Porto Alegre,
2026

"Eles dizem representação. Nós dizemos experimentação. Eles dizem identidade. Nós dizemos multidão. Eles dizem língua nacional. Nós dizemos tradução multi código. Eles dizem dominar a periferia. Nós dizemos mestiçar o centro. Eles dizem dívida. Nós dizemos cooperação sexual e interdependência somática. Eles dizem despejo. Nós dizemos habitemos em comum. Eles dizem capital humano. Nós dizemos aliança multiespécies. Eles dizem diagnóstico clínico. Nós dizemos capacitação coletiva. Eles dizem disforia, transtorno, síndrome, incongruência, deficiência, menos-valia. Nós dizemos dissidência corporal.

Paul B. Preciado

SIGLAS

CAPS: Centro de Atenção Psicossocial

EPS: Educação Permanente em Saúde

LGBTQIA+: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Intersexos, Assexuais

RAPS: Rede de Atenção Psicossocial

ANTRA: Associação Nacional de Travestis e Transexuais

SUS: Sistema Único de Saúde

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Respostas da questão 1.....	45
Gráfico 2 - Respostas da questão 2.....	46
Gráfico 3 - Respostas da questão 4.....	47
Gráfico 4 - Respostas da questão 5.....	48
Gráfico 5 - Respostas da questão 6.....	49
Gráfico 6 - Resposta da questão 7.....	50
Gráfico 7 - Respostas da questão 8.....	51
Gráfico 8 - Respostas da questão 10.....	53

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Quadro com diferentes modalidades de CAPS.....	38
Quadro 2 - Categorização das respostas da questão 9.....	53
Quadro 3 - Categorização das respostas da questão 12.....	56
Quadro 4 - Categorização das respostas da questão 13.....	60
Quadro 5 - Categorização das respostas da questão 14.....	61
Quadro 6 - Categorização das respostas da questão 15.....	62

GLOSSÁRIO¹

Assexual: pessoa que não sente atração sexual, ou sente de forma parcial, ou em condições específicas.

Bissexual: Pessoa que sente atração sexual e afetiva independente do gênero².

Cisgênero: Pessoa que se identifica com o gênero que lhe é socialmente designado ao nascer.

Drag Queen/ Drag king: Pessoa que performa outras expressões de gênero para fins artísticos.

Gay: Pessoa que se identifica como homem e sente atração sexual e afetiva por homens.

Heterossexual: Quem sente atração por gênero diferente do seu - em uma lógica binária.

Homem trans: Pessoa para a qual foi atribuído o gênero feminino ao nascer, mas que se identifica com o gênero masculino (identidade de gênero).

Homossexual: pessoa sente atração pelo mesmo gênero.

Identidade de gênero: Define com que gênero a pessoa se identifica - masculino, feminino ou outro -, independe da orientação sexual e de características físicas.

Intersexual: Pessoa que apresenta características sociais congênitas que não se enquadram nas normas físicas e sociais para a categorização de corpos em feminino ou masculino.

Lésbica: Pessoa que se identifica como mulher e sente atração sexual e afetiva por mulheres.

Mulher trans: Pessoa para a qual foi atribuído o gênero masculino ao nascer, mas que se identifica como mulher (identidade de gênero).

¹ Este glossário foi produzido a partir da experiência social em movimentos sociais, bem como da leitura dos glossários produzidos pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (<https://defensoria-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202306/21144758-glossario-da-diversidade-2-edicao.pdf>) e pelo Instituto de Estudos de Gênero da UFSC (<https://ieg.ufsc.br/noticias/497>).

² Segundo o Manifesto Bissexual Brasileiro, publicado pela Frente Bissexual Brasileira em 2021 (<https://www.frentebissexualbrasileira.org/manifesto-bissexual-brasileiro>), bissexuais são “pessoas para quem o gênero não é um fator determinante da atração sexual ou afetiva”. Essa é uma discussão no movimento social, alguns setores afirmam que bissexuais se atraem somente por homens e mulheres - o que não inclui pessoas não binárias, outras defendem a visão mais ampla que aqui consta.

Não-binário: Pessoa que não se identifica com nenhum dos generos do padrão binário, não se restringindo a lógica binária. Podem não se identificar com nenhum gênero, com ambos, ou transitar entre os gêneros.

Orientação sexual: Define por quem se sente atração.

Pansexual: Pessoa para a qual a atração afetiva e sexual independe do gênero.

Queer: Pessoa que não se encaixa nos padrões impostos pela heterocisnormatividade, podem transitar entre gêneros.

Transgênero: Pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi socialmente designado.

Travesti: Pessoa que ao nascer teve atribuído a si o gênero masculino, mas se identifica com o gênero feminino. O termo carrega uma importância política, surge como uma tentativa de ofensa, e é ressignificado como expressão de resistência.

RESUMO

Introdução: O presente estudo foi realizado na cidade de Canoas - cidade de médio porte na região metropolitana de Porto Alegre no Rio Grande do Sul e busca refletir acerca do cuidado em saúde mental da população LGBTQIA+ no âmbito do Sistema Único Saúde, analisando as dinâmicas do preconceito contra pessoas LGBTQIA+ e a percepção dos trabalhadores dos CAPS sobre o atendimento dessa população nos serviços especializados para o cuidado em saúde mental no SUS.

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, foram participantes da pesquisa pessoas que integram as equipes dos cinco CAPS do município - respondendo um questionário estruturado; e participando de roda de conversa sobre a temática posteriormente. Aparece como questão central desta pesquisa: a dinâmica do cuidado em saúde mental da população LGBTQIA+ no âmbito do Sistema Único Saúde, nos serviços especializados para esse cuidado - os Centros de Atenção Psicossocial. Para investigar tal questão, refletimos sobre a formação de trabalhadores para atender essa população; como é a adesão ao cuidado por parte das pessoas LGBTQIA+; entre outros pontos. **Objetivos:** O objetivo geral desta pesquisa foi investigar como se dá o cuidado em Saúde Mental da população LGBTQIA+ no cotidiano dos Centros de Atenção Psicossocial em um município de médio porte no estado do Rio Grande do Sul; já os objetivos específicos foram os seguintes: mapear como trabalhadores avaliam o cuidado à população LGBTQIA+ nos CAPS; mapear como os trabalhadores avaliam a aderência ao cuidado da população LGBTQIA+; investigar quais são as demandas específicas trazidas por essa população e como se dá o cuidado nestes serviços; analisar como é a formação das e dos trabalhadores dos serviços sobre identidade de gênero, orientação sexual e saúde mental da população LGBTQIA+; e mapear se tem acontecido e como tem sido as ações de Educação Permanente em Saúde sobre essa temática nos CAPS. **Resultados e discussão:** Em relação aos resultados aparecem como pontos positivos: a realização de ações de educação permanente trazida por boa parte dos participantes; a preocupação com o cuidado humanizado; a preocupação com a busca de formação por boa parte das equipes; a capacidade de avaliar e enxergar as demandas da população LGBTQIA+, assim como de reconhecer a LGBTfobia como disparador importante de sofrimento, demonstrada pelas equipes; entre outros. Como pontos negativos podemos citar: o déficit na formação inicial dos trabalhadores sobre a temática; as falas de que ainda há preconceitos reproduzidos por membros das equipes; o desconhecimento de termos e conceitos básicos por parte das equipes - que não se configura como um problema individual; entre outros. **Aplicabilidade na saúde coletiva:** A partir dos elementos das respostas dos questionários e da discussão em roda de conversa, foi possível refletir o dia a dia do cuidado nos CAPS, bem como potencialidades e pontos a serem melhorados para ofertar um cuidado alinhado com os princípios do SUS. Como produto desta pesquisa, foi construída cartilha para embasar o cuidado desta população e ações de educação permanente em saúde sobre essa temática nos CAPS. **Considerações finais:** Por fim, essa pesquisa indica uma necessidade da manutenção - e do fortalecimento - da educação permanente nos CAPS. Aponta também para a necessidade da revisão de documentos, sistemas de prontuário eletrônicos e fluxos de trabalho - para não deixar espaço para a reprodução de LGBTfobia.

Palavras-chave: saúde mental; população LGBTQIA+; CAPS.

ABSTRACT

Introduction: The present study was conducted in the city of Canoas—a medium-sized city in the metropolitan region of Porto Alegre, Rio Grande do Sul—and seeks to reflect on the mental health care of the LGBTQIA+ population within the scope of the Unified Health System (Sistema Único de Saúde - SUS). It analyzes the dynamics of prejudice against LGBTQIA+ individuals and the perception of CAPS (Centros de Atenção Psicossocial / Psychosocial Care Centers) workers regarding the care provided to this population in specialized mental health care services within the SUS. **Methodology:** This is a qualitative research study. The participants were staff members from the municipality's five CAPS, who answered a structured questionnaire and subsequently participated in a conversation circle (roda de conversa) on the theme. The central question of this research emerges as: the dynamics of mental health care for the LGBTQIA+ population within the scope of the Unified Health System in specialized services for this care—the Psychosocial Care Centers. To investigate this issue, we reflected on the training of workers to serve this population, adherence to care by LGBTQIA+ individuals, among other points. **Objectives:** The general objective of this research was to investigate how mental health care for the LGBTQIA+ population takes place in the daily routine of Psychosocial Care Centers in a medium-sized municipality in the state of Rio Grande do Sul. The specific objectives were as follows: to map how workers evaluate care for the LGBTQIA+ population in the CAPS; to map how workers evaluate adherence to care by the LGBTQIA+ population; to investigate the specific demands brought by this population and how care is delivered in these services; to analyze the training of service workers regarding gender identity, sexual orientation, and the mental health of the LGBTQIA+ population; and to map whether Continuing Health Education (Educação Permanente em Saúde) actions on this theme have been occurring and how they have been carried out in the CAPS. **Results and discussion:** Regarding the results, positive points include: the implementation of continuing education actions reported by a large portion of the participants; the concern with humanized care; the commitment to seeking training by a significant part of the teams; and the capacity demonstrated by the teams to evaluate and perceive the demands of the LGBTQIA+ population, as well as to recognize LGBTphobia as an important trigger for suffering, among others. As negative points, we can mention: the deficit in the workers' initial training on the theme; reports indicating that prejudices are still reproduced by team members; and the lack of knowledge regarding basic terms and concepts by the teams—which is not framed as an individual problem, among others. **Applicability in public health:** Based on the elements from the questionnaire responses and the discussion in the conversation circle, it was possible to reflect on the daily routine of care in the CAPS, as well as the potentials and points to be improved to offer care aligned with the principles of the SUS. As a product of this research, a booklet (cartilha) was developed to support the care of this population and to guide continuing health education actions on this theme within the CAPS. **Final considerations:** Finally, this research indicates a need for maintaining—and strengthening—continuing education in the CAPS. It also points to the need for reviewing documents, electronic medical record systems, and workflows to leave no room for the reproduction of LGBTphobia.

Keywords: mental health; LGBTQIA+ population; CAPS.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	12
1. MÉTODO E METODOLOGIA.....	16
CONSIDERAÇÕES ÉTICAS.....	19
A REDE PESQUISADA.....	20
2. COMO ESTÁ A SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO LGBTQIA+?.....	22
3. OPRESSÕES: UM COMPONENTE DA SOCIEDADE EM QUE VIVEMOS.....	23
CAPITALISMO, CONJUNTURA BRASILEIRA E POPULAÇÃO LGBTQIA+.....	27
4. IDENTIDADE DE GÊNERO, ORIENTAÇÃO SEXUAL, PADRÕES DE GÊNERO E HETEROCISNORMATIVIDADE.....	30
5. SAÚDE MENTAL NO BRASIL.....	34
UMA HISTÓRIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS E TORTURA.....	34
LUTA ANTIMANICOMIAL E REFORMA PSIQUIÁTRICA.....	35
CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.....	37
Quadro 1: Quadro com diferentes modalidades de CAPS.....	38
RETROCESSOS NAS POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL E CENÁRIO ATUAL.....	39
6. POPULAÇÃO LGBTQIA+ E ACESSO À SAÚDE.....	41
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DE LGBTs.....	42
7. RESULTADOS, APONTAMENTOS E REFLEXÕES.....	45
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	65
REFERÊNCIAS.....	67
APÊNDICE I- QUESTIONÁRIO.....	70
APÊNDICE II- CARTILHA.....	70

INTRODUÇÃO

Iniciei minha trajetória profissional na saúde mental em 2017, trabalhando como estagiária em um Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS IJ) que atende crianças e adolescentes. De 2019 a 2021 trabalhei em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III), um CAPS III e uma internação psiquiátrica em um hospital geral, como parte da Residência em Saúde Mental Coletiva. Em maio de 2021 fui contratada como professora de educação física em um CAPS AD III. Em maio de 2023 assumi a coordenação de um CAPS II adulto, cargo que ocupei durante boa parte desta pesquisa e do qual sai no fim de janeiro de 2026. Tanto as experiências como residente, como os trabalhos posteriores, aconteceram e acontecem no município que hoje é o campo desta pesquisa. Em minha experiência em diferentes modalidades de Centros de Atenção Psicossocial - como estagiária, residente, trabalhadora contratada e coordenadora - pude observar que, em muitos momentos, pessoas LGBTQIA+ acessavam o serviço, mas pouco se refletia na equipe os efeitos da LGBTfobia na saúde mental da população (e especificamente da pessoa que estava sendo atendida). Pude observar também que a formação inicial da equipe para atender essa população apresentava muitas lacunas - como, por exemplo, a dificuldade em compreender a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero; e a insistência no uso do nome de registro de pessoas trans - e não raro somente quem trazia essas questões para discussão eram aquelas pessoas da equipe que são LGBTQIA+.

Organizei ações de Educação Permanente em Saúde sobre o cuidado em saúde mental da população LGBTQIA+ em diferentes CAPS e para a rede de Saúde Mental do município que atuo. Essas ações se deram nas reuniões de equipe semanais, que ocorrem na quarta pela manhã; assim como na Roda de Conversa da Saúde Mental, que conta com a presença de todos os CAPS do município e é realizada mensalmente. Nesses momentos, a discussão foi produtiva, demonstrando um déficit formativo, mas também um interesse importante na temática.

Em relação a pesquisas e estudos que embasam as políticas públicas de saúde, há ainda hoje poucos dados sobre a saúde mental da população LGBTQIA+ no Brasil. Apesar dos escassos dados, é justo nos perguntarmos como a LGBTfobia sofrida por essa população tem impactos na saúde mental, considerando essa

forma de preconceito como um determinante social de saúde (e de saúde mental) para essa população.

Ao longo deste estudo, trarei pesquisas que nos dão elementos para pensar o adoecimento e o sofrimento mental da população LGBTQIA+, bem como a prevalência de ideação suicida e tentativas de suicídio em relação à população heterossexual e cisgênero. Por hora, vale citar também pesquisa realizada no interior do estado de São Paulo, onde adolescentes homossexuais tinham em torno de duas vezes mais chances de apresentar pensamentos suicidas do que adolescentes heterossexuais (TEIXEIRA-FILHO and RONDINI, 2012).

Quando pensamos no acesso à educação e ao trabalho – dois fatores condicionantes da saúde – vemos que há também uma precarização da vida nessas dimensões. Uma pesquisa realizada pela UNESCO, em 2004, nas redes pública e privada de educação de Porto Alegre demonstrou que 17% dos professores do município consideravam que homossexualidade uma doença (JUNQUEIRA, 2009).

Uma pesquisa por “saúde mental” e termos relacionados à LGBT retornam poucos estudos nos buscadores - mapa da produção encontra-se nos apêndices. Ao refinarmos estas buscas por estudos sobre população LGBT e o acesso e tratamento nos CAPS, temos ainda menos estudos. Os CAPS são os serviços substitutivos instituídos pela Reforma Psiquiátrica como serviços especializados em saúde mental no Sistema Único de Saúde - a escassez de estudos sobre a população LGBTQIA+ nestes dispositivos foi um dos motivadores para a realização dessa pesquisa.

No Brasil o que precede a Reforma Psiquiátrica é um passado bastante violento no que tange ao tratamento em saúde mental. Os hospitais psiquiátricos eram locais de isolamento e tortura, para onde eram mandadas não só pessoas que apresentavam algum transtorno mental, mas aquelas que não se encaixavam nos padrões socialmente impostos, dissidentes da norma, inclusive as pessoas LGBTQIA+.

O presente estudo busca refletir acerca do cuidado em saúde mental da população LGBTQIA+ no âmbito do Sistema Único Saúde, analisando as dinâmicas do preconceito contra pessoas LGBTQIA+ e a percepção dos trabalhadores dos CAPS sobre o atendimento dessa população nos serviços especializados para o cuidado em saúde mental no SUS. Foram participantes da pesquisa pessoas que

integram as equipes dos cinco CAPS do município - respondendo um questionário estruturado; e participando de roda de conversa sobre a temática posteriormente.

Aparece como questão central desta pesquisa: a dinâmica do cuidado em saúde mental da população LGBTQIA+ no âmbito do Sistema Único Saúde, nos serviços especializados para esse cuidado - os Centros de Atenção Psicossocial. Para investigar tal questão, refletimos sobre a formação de trabalhadores para atender essa população; como é a adesão ao cuidado por parte das pessoas LGBTQIA+; entre outros pontos.

O objetivo geral desta pesquisa é investigar como se dá o cuidado em Saúde Mental da população LGBTQIA+ no cotidiano dos Centros de Atenção Psicossocial em um município de médio porte no estado do Rio Grande do Sul e a partir daí construir cartilha para embasar o cuidado desta população e ações de educação permanente em saúde sobre essa temática nos CAPS. Já os objetivos específicos são os seguintes:

- Mapear como trabalhadores avaliam o cuidado à população LGBTQIA+ nos CAPS;
- Mapear como os trabalhadores avaliam a aderência ao cuidado da população LGBTQIA+;
- Investigar quais são as demandas específicas trazidas por essa população e como se dá o cuidado nestes serviços;
- Analisar como é a formação das e dos trabalhadores dos serviços sobre identidade de gênero, orientação sexual e saúde mental da população LGBTQIA+; e
- Mapear se tem acontecido e como tem sido as ações de Educação Permanente em Saúde sobre essa temática nos CAPS;

Estes objetivos foram trabalhados nas diferentes etapas da pesquisa, e teve desdobramentos nas discussões trazidas e realizadas com as pessoas das equipes dos CAPS.

A seguir, descrevo de forma mais detalhada a metodologia aplicada nesta pesquisa, bem como a rede onde a pesquisa foi realizada. Em seguida, trago discussões teóricas e de estudos sobre a temática trabalhada. Após, a análise dos dados provenientes dos diferentes momentos do estudo e, por fim, as conclusões;

consta também cartilha sobre o cuidado em saúde mental da população LGBTQIA+ (Apêndice II), produto desta pesquisa.

1. MÉTODO E METODOLOGIA

A pesquisa em questão adotou uma abordagem qualitativa, visando explorar e compreender as percepções e experiências dos participantes de maneira aprofundada. Em relação ao seu caráter exploratório, é importante destacar alguns esforços necessários: disciplina, para haver uma prática sistemática; crítica, como forma de estabelecer relações entre o objeto e a teoria; e deve ser ampla, no sentido de investigar o “conhecimento geral” disponível – ou parte dele – sobre o objeto de estudo (MINAYO, 2002).

É importante ressaltar que utilizo nesta pesquisa (como conceito e prática de pesquisa), a ideia do pesquisador In-mundo. A implicação do pesquisador é intrínseca à produção de conhecimento, o que significa que o pesquisador não ocupa uma posição de neutralidade, mas sim de ação política. Essa perspectiva reconhece que a produção de conhecimento é um processo ativo e engajado, onde o pesquisador está profundamente envolvido e influenciado pelo mundo ao seu redor. Nesse conceito, a implicação é intrínseca a produção de conhecimento e o pesquisador desempenha simultaneamente ações de produção de conhecimento e de ação política (GOMES and MEHRY, 2014):

Assume-se, assim, que não há neutralidade na produção de conhecimento e que o pesquisador implicado, transita pelo território das suas implicações como sujeito in-mundo, ele produz e se produz na construção de conhecimento (GOMES e MEHRY, 2014, p. 159).

Nesta perspectiva, a pesquisa é vista não apenas como uma forma de intervenção no mundo, mas também como um processo de ser afetado por ele. No meu caso, como coordenadora de um dos CAPS que servirá como campo de pesquisa, estou diretamente inserida no contexto no qual foi realizada a pesquisa. Isso me posiciona não apenas como pesquisadora, mas também como participante ativa na construção diária do serviço e da rede, influenciando e sendo influenciada pelas dinâmicas e desafios do ambiente em que atuo.

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário como instrumento, aplicado de forma presencial junto aos trabalhadores e trabalhadoras dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Canoas. Em um segundo momento, foi

realizada uma roda de conversa com as equipes, a partir da análise das respostas e de conceitos pertinentes à temática, na edição seguinte da Roda de Saúde Mental. Estas duas etapas descritas - coleta e discussão/devolutiva dos dados - foram realizadas no segundo semestre de 2025. No total, 34 pessoas responderam o questionário e cerca de 40 pessoas participaram da roda de conversa onde a pesquisa foi discutida.

A aplicação dos questionários ocorreu no início de uma das edições da Roda de Saúde Mental de Canoas, um evento que reúne profissionais da área para discutir e promover a saúde mental. Estes profissionais integram a equipe multiprofissional dos CAPS. Os participantes responderam ao questionário em seus próprios dispositivos móveis, acessando-o por meio de um QR code. Essa abordagem visou facilitar o acesso e a conveniência, além de promover a sustentabilidade ao reduzir o uso de papel.

Uma característica importante do questionário é a possibilidade de anonimato, o que pode incentivar respostas mais sinceras e autênticas. A confidencialidade das respostas é fundamental para minimizar possíveis constrangimentos e permitir que os participantes expressem suas opiniões e experiências de forma aberta e honesta. De acordo com Coutinho e Cunha (2014), essa estratégia pode aumentar a qualidade e a veracidade dos dados coletados, contribuindo para uma análise mais precisa e significativa dos resultados da pesquisa.

O questionário é uma outra técnica de observação das mais valiosas para a coleta de informações nos vários campos de conhecimento. O questionário é dirigido para se obter do indivíduo um relato por escrito de suas experiências próprias, de seus conhecimentos, suas simpatias e idiossincrasias. As perguntas podem ser também sobre outras pessoas, sobre algum acontecimento ou fenômeno.[...] Uma grande vantagem do questionário é o anonimato: o fato de não ser identificado deixa o respondente muito a vontade para dar respostas verdadeiras (COUTINHO AND CUNHA, 2014, p. 113 e 115).

As respostas dos questionários foram analisadas qualitativamente, através da metodologia de Análise de Conteúdo (MINAYO, 2007). São procedimentos metodológicos utilizados na análise de conteúdo em pesquisas qualitativas: categorização, inferência, descrição e interpretação. Em relação à trajetória para análise do conteúdo obtido, temos as seguintes etapas: leitura compreensiva do

material, de forma exaustiva; exploração do material, momento em que se faz a análise propriamente dita; e, a última etapa, síntese interpretativa, através do diálogo com temas, questões e referências (MINAYO, 2007).

Minayo (2007) argumenta que "chegamos a uma interpretação quando conseguimos realizar uma síntese entre as questões da pesquisa; os resultados obtidos a partir da análise do material coletado, as inferências realizadas e a perspectiva teórica adotada." (p. 91). Dessa forma, busco neste trabalho, produzir sínteses a partir do conteúdo analisado, mediada pela metodologia e o instrumento indicados, partindo da compreensão de que o estudo de um dado objeto, a pesquisa e a ciência de forma geral, não são produzidos de forma dissociada da visão de mundo de quem produz, o objeto de estudo não é dissociado da sociedade de forma geral e deve ser estudado a partir de sucessivas aproximações e como resultado de múltiplas determinações sociais (NETO, 2011).

Após a compilação dos dados e sua análise inicial, levamos estes resultados preliminares para serem discutidos com os colaboradores da pesquisa, na Roda de Conversa de Saúde Mental. O objetivo dessa etapa foi promover uma discussão aberta e colaborativa, permitindo que os participantes oferecessem suas percepções e insights sobre os achados iniciais. Durante a roda de conversa, os colaboradores tiveram a oportunidade de refletir sobre os resultados, levantar questões, e sugerir interpretações adicionais que enriqueceram a análise. Essa interação não apenas validou os dados coletados, mas também fortaleceu o engajamento dos participantes, garantindo que suas vozes fossem ouvidas e consideradas no processo de pesquisa. A troca de ideias nesse ambiente colaborativo revelou novas perspectivas e contribuiu para um entendimento mais profundo dos temas investigados.

A partir da análise de dados e de referencial teórico, assim como das discussões realizadas na roda de conversa, foi construída cartilha para auxiliar no cuidado em saúde mental a essa população, bem como embasar ações de educação permanente em saúde nos CAPS (ver apêndice II).

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Essa pesquisa respeitou as normas que constam na Portaria CNS466/2012. Para tal, em relação à pesquisa com seres humanos, essa pesquisa atendeu os seguintes fundamentos éticos e científicos:

- “a) respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida;
 - b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos;
 - c) garantia de que danos previsíveis serão evitados; e
 - d) relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária.”
- (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012)

Foi solicitada a autorização do município onde aplicamos o questionário de forma presencial; cada um/a das/os trabalhadoras/es teve um espaço no início do formulário para assinalar a concordância com a participação na pesquisa (texto adaptado do termo de consentimento livre e esclarecido); este projeto foi autorizado pelo Núcleo Municipal de Saúde Coletiva (NUMESC) de Canoas - município onde a pesquisa foi realizada e pelo CEP da UFRGS.

A participação das/os trabalhadoras/es se deu de forma gratuita e voluntária. Esta pesquisa apresenta riscos mínimos, foi realizada em espaço já planejado para os trabalhadores estarem, em seu cotidiano, de forma anônima. A participação nesta pesquisa não traz complicações legais de nenhuma ordem e os procedimentos utilizados obedecem aos critérios da ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde. Serão utilizados meios virtuais para a realização dos questionários. Apesar dos riscos de quebra de confidencialidade, inerentes a esses meios, o questionário foi realizado sem a necessidade de identificação - logo, de forma totalmente anônima e só terão acesso aos dados os pesquisadores envolvidos nesta pesquisa, reduzindo assim os riscos inerentes. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos à sua dignidade.

A REDE PESQUISADA

O município de Canoas tem uma população de cerca de 360 mil habitantes e faz parte da Região Metropolitana de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Conta com

REFERÊNCIAS

ARBEX, Daniela. **Holocausto brasileiro**: genocídio: 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2013.

ASSUNÇÃO, Iuri. Heterossexismo, patriarcado e diversidade sexual. *In*: NOGUEIRA, Leonardo (org.). **Hasteemos a bandeira colorida**: diversidade sexual e de gênero no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 2018.

BAPTISTA, Luis Antonio; ENGEL, Magali Gouveia. A construção do manicômio e as interpelações da história. **Revista Psicologia Clínica**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, 2001.

BASTOS, João Luiz; FAERSTEIN, Eduardo. **Discriminação e saúde**: perspectivas e métodos. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012.

BAUER, G. R. *et al.* Intervenable factors associated with suicide risk in transgender persons: a respondent driven sampling study in Ontario, Canada. **BMC Public Health**, [s. l.], v. 15, n. 525, 2015.

BOLZAN, Liana de Menezes. **Deméter, Ceres e Bacante**: homogeneização da mulher que faz uso de drogas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016.

BRASIL. [Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001]. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 138, n. 69, p. 2, 9 abr. 2001.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011**. Institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html. Acesso em: 4 ago. 2024.

CARVALHO, Kauan Gustavo *et al.* Comportamento suicida em minorias sexuais: prevalência e fatores associados. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 11, n. 14, 2019.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Tentativas de aniquilamento das subjetividades LGBTIs**. Brasília, DF: CFP, 2019.

COUTINHO, Maria Tereza da Cunha; CUNHA, Suzana Ezequiel da. **Os caminhos da pesquisa em ciências humanas**. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2014.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RS. **Glossário da Diversidade**. Porto Alegre, RS, 2024.

ENGELMAN, Selda. O campo da exceção e a vida nua. *In*: FONSECA, Tânia Mara Galli; ENGELMAN, Selda; PERRONE, Cláudia Maria (org.). **Rizomas da Reforma Psiquiátrica**. Porto Alegre: Editora da UFRGS/Sulina, 2007.

FRENTE BISSEXUAL BR. **Manifesto Bissexual Brasileiro**. Brasil, 2021.

GOFFMAN, Erving. **Manicômios, prisões e conventos**. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007. (*Nota: corrigido o erro de digitação no nome: Goffman*).

GOMES, Maria Paula Cerqueira; MERHY, Emerson Elias (org.). **Pesquisadores IN-MUNDO**: um estudo da produção do acesso e barreira em saúde mental. Porto Alegre: Rede UNIDA, 2014.

GOMES, Fraikson Cleiton Fuscaldi; SILVA, José Bruno Aparecido da. Os suplícios e a expressão da sociedade punitiva no Hospital Colônia, o maior manicômio do país. **Revista Científica Univiçosa**, Viçosa, v. 10, n. 1, 2018.

HATZENBUEHLER, M. L.; KEYES, K. M. Inclusive anti-bullying policies and reduced risk of suicide attempts in lesbian and gay youth. **Journal of Adolescent Health**, [s. l.], v. 53, n. 1, 2013.

MANIFESTO DE BAURU. **Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental**. Bauru, SP, 1987.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2007.

NETTO, José Paulo. **Introdução ao estudo do método de Marx**. São Paulo: Expressão Popular, 2011.

PEREIRA, Lourenço Barros de Carvalho; CHAZAN, Ana Cláudia Santos. Acesso das pessoas transexuais e travestis à atenção primária à saúde: uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 41, 2019.

PRECIADO, Paul B. **Um apartamento em Urano**: crônicas da travessia. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA: princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Tradução de Jones de Freitas. [S. l.], 2007.

TEIXEIRA-FILHO, Fernando Silva; RONDINI, Carina Alexandra. Ideações e tentativas de suicídio em adolescentes com práticas sexuais hetero e homoeróticas. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 21, n. 3, p. 651-667, 2012.

THOMAZI, Guilherme Lampert; RATES, Aline Schwalm Andrade; ÁVILA, Simone. Isolamento social pra quem? Notas sobre a pandemia da COVID-19 e suas consequências na vida das pessoas trans no Brasil. *In*: MARTINS, Aline Blaya *et al.* (org.). **A pandemia e a saúde coletiva**: produzindo conhecimentos e tecnologias no cotidiano. São Leopoldo: Oikos, 2021.

WARNER, Michael. Introduction. *In*: WARNER, Michael (ed.). **Fear of a queer planet**: queer politics and social theory. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.